EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL	:	HOSPITAL DE SAN CARLOS	N° EGRESO	:	75449
SERVICIO	:	MEDICINA HSC			
FECHA	:	2023-12-07 12:30:00			

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: VICTOR ORLANDO PALAVECINO JELDRES			RUN	: 6.910.313-8
F.Nac	: 11-08-1952	Edad	: 71 AÑOS, 3 MESES	Género	: Masculino
Dirección	: V MACKENNA 029			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA C	Teléfono	: 0		
Fecha Ingreso	: 2023-12-02	Fecha Egreso	: 2023-12-07 12:30:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. J18.9-NEUMONIA, NO ESPECIFICADA

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. I50-INSUFICIENCIA CARDIACA (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)
2. I83.0-VENAS VARICOSAS DE LOS MIENBROS INFERIORES CON ULCERA (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Dia 5 de hospitalización
idx . Insuficiencia Crdiaca Descompasada
-ICC Fevi Desconocida , descomepnsda
-Derrame Pleural Derecho resuelto.
-Cardiopatia Cornoanria CRM 2022 (Lima ada / RIma M1 /PAC 1 DG / Pac ACDP)
-HTA
-Tabaquismo abandonado
-Obesidad
-ERC II crea basal 1.5
Paciente ingresado por insuficiencia cardiaca descompensada, asociada a cuadro respiratorio, concomitante a esto presenta ulcera extensa en pierna derecha de larga data.
Se realiza ecocardiograma que muestra: Ventriculo izquierdo dilatado con funcion sistolica severamente reducida, disfuncion diastolica grdo 1, trastornos de cinesia segmentarios y globales descritos.
- insuficienica mitral y tricuspide leve (infraestimadas por fc)
- ventriculo derecho dilatado hipocontractil.
- dlatacion biauricular.
- fibrilacion auricular con respuesta ventricular rapida todo el estudio.

Es evaluado por cardiología quien da indicaciones farmacológicas y solicita controlarlo dentro de 1 semana.
Paciente refiere sentirse bien, HDE autosostenida, afebril, asintomatico.
Pa 104/65, fc 80 sat 97 % ambiental
Por ulcera extensa en pierna derecha, ayer valorada por cirugía e indican mantener curaciones por enfermería, terbinafina crema en la noche y toma de eco doppler arterial de pierna y control si no evoluciona favorablemente.

Se determina continuar manejo en Hospitalización domiciliaria para curaciones.

PLAN DE MANEJO:

Eco doppler arterial de pierna izquierda el día 12/12 a las 11:00 am
Rescatar cultivo de herida el día de Sabado 09/12
Control por cardiología la semana próxima.

INDICACIONES AL ALTA

1. Reposo relativo
2. Regimen estricto sin sal
3. Restricción hídrica de 1lt día
4. Flucloxacilina 500mg 1 c 8hrs por 7 días
5. Furosemida 40mg 1 a las 8 am y 1 a las 15:00 pm vo
6. Bisoprolol 2,5mg 2 c dia
7. Espironolactona 25mg 1 c dia
8. Omeprazol 20mg vo
9. Entresto 1 c 12hrs vo
10. Empaglifozina 10mg 1 c dia vo
11. Espironolactona 25mg 1 c dia vo
12. Terbinafina crema aplicar en las noches
13. Curaciones avanzadas por enfermería dia por medio

PANIQUE PEDRAZA MARIANA ANDREA
MEDICO TRATANTE
24689611-9

JEFE SERVICIO